

JORGE LUIZ ALMEIDA

MEDICAMENTOS:	Proglidão / Rosartatino / Tandiace / Glifage / Rivotril
SINTOMAS/QUEIXAS	Briga / dores / Sonha muito
BANHEIRO	2x à 3x
HORA QUE ACORDA	10h
HORA QUE DORME	2h
	Clonazepam - 5gr.
	angioplastia em março 2022
PRATICA EXERCICIO	não faz

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE: 10:30 ALMOÇO: 14h LANCHE: 20 JANTA: Não

~~10/09~~ 22 P= 5cmH₂O
Adapten ao CPAP. Jua

~~19/09~~ 22 P= 5cmH₂O
IAH= 5,7 l/h
m. de uso: 6h47'
Bem adaptado. Jua

~~04~~ 10 22 P= 5cmH₂O
IAH= 3,7 l/h
Boucheiro 1 no max 2x
m. de uso: 5h35'
Orientei sobre higienização. Jua

~~01~~ 11 22 P= 5cmH₂O
IAH= 5,5 l/h
m. de uso: 4h57'
Bem adaptado ao uso do CPAP. Jua

~~06/02~~ 23 P= 5cmH₂O
IAH= 3,2 e l/h
m. de uso: 5h30'
Fuga = 19,6 l/min. Jua

~~08/05~~ 23 P= 5,4cmH₂O
IAH= 2,9 e l/h
m. de uso: 5h40'
Fuga = 28 l/min Jua

~~10/07/23~~ P= 5,8 cmH₂O fixa.
IAH= 3,7 e l/h
m. de uso= 5h30' novo filtro
fuga= 11,3 l/min

~~10/09~~ 23 P= 5,8 cmH₂O Bem adaptado. Jua
IAH= 0,8 e l/h

11/12 P= 5,8 cmH₂O
2023 IAH= 2,6 e/h
m. uso: 3h36'
fuga: 11,6.

fica à noite qdo dorme - sem perceber
hagou nos dentes - 10 dias

28/02 P= 5,8 cmH₂O
=4 IAH= 2,8 e/h
m. de uso: 4h30'

Troco o filtro

fua

16/05 P= 5,8 cmH₂O
24 IAH= 1,0 e/h
m. de uso: 5h24'

Bem adaptado, sem queixa
fua

21/07 P= 5,8 cmH₂O
24 m. de uso: 6h
IAH= 1,2 e/h
Fuga= 9 e/h

fua

31/10 P= 8,1 cmH₂O
24 IAH= 0,7 e/h
m. de uso: 6h12'
Fuga= 10,6

Não está fazendo exere.

fua Cláudio

31/01
2025 P= 5,8 cmH₂O
IAH= 1,4 e/h
m. uso: 5h30'
fuga= 11 min

Está mudando medicação neuro-psiquiátrica
devido pernas inquietas / sono agitado
- suspendeu Zivohil; iniciou Sertralina
e vai avaliar melatonina d. psiquiatria

* trocou filtro *

Silvia

11/06
2025 P= 5,8 cmH₂O
IAH= 1,4 e/h
m. uso: 6h45 min.
fuga= 20 l min

noite pelo psiquiatria pl sono REM
Sertralina.

ajustamância trocou filtro

Atividade física.

Silvia

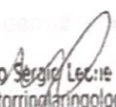
Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologia

Paciente: **JORGE LUIZ DE ALMEIDA** (65 anos)
Convênio: **Petrobras**
Matrícula: **010630759200**

Relatorio medico.

*Paciente com indicação de uso de CPAP para SAHOS moderada ,
necessitando ajuste fino da pressão . Na titulação apresentou
melhora com pressão de 5,0 cm de H2O.*

São José dos Campos, 06 de setembro de 2022


Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologista

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
CRM 57250

Sinopse
Frio Ana Claudia
lus. hanta Ela 418
3921 1001

Av. Mal. Floriano Peixoto, 347 - 4. And Sala 402 Centro Fone: (12) 3922-5011
Cep 12210-030 São José dos Campos / SP

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: JORGE LUIZ DE ALMEIDA			
Sexo: M	Idade: 59 anos	Peso: 72 Kg	Altura: 1,66 m
IMC: 26,1	Data do Exame: 11/01/2016	Exame: 50906_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:27:41 horas e encerrado às 05:51:41 horas, com latência para o sono de 6 minutos e latência para o sono REM de 77 minutos. O tempo total de sono foi de 306,5 minutos, com eficiência do sono de 69,0%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	4,6%	Até 5%
Estágio 2	81,2%	45 - 55%
Estágio 3	8,2%	> 15%
Sono REM	6,0%	20 - 25%
Eficiência do sono	69,0%	> 85%

No período total de sono permaneceu 137,5 minutos acordado e ocorreram 55 micro despertares (índice de 10,8 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 63 bpm , a maior de 76 bpm e a menor de 56 bpm.

Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 42 eventos respiratórios, sendo 0 central, 42 obstrutivos e 0 misto. O índice de apnéia/hipopnéia total foi 8,2/hora, sendo 1,0 apnéia/hora e 7,2 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 3,2/hora, sendo 0,0 apnéia/hora e 3,2 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 94%, a maior de 97% e a mínima de 88%, permanecendo 0,4 minutos (0,1%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 22 dessaturações.

Resumo dos resultados

- Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau leve (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- Dessaturações da Oxihemoglobina.
- Registro de ronco.
- Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 0/hora).
- Eficiência do sono diminuída.

Bruno de Andrade Soares
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 104075

PÓS CIRURGICO

INSTITUTO DO
SONO

Instituto do Sono
Rua Marselhesa, 500 – Vl. Clementino
São Paulo – SP – CEP 04020-060
Tel.: (11) 2108-7777

Nome: JORGE LUIZ DE ALMEIDA

Sexo: M

Idade: 59 anos

Exame nº: 17515919

Peso: 74 Kg

Altura: 1,66 m

Data: 06/10/2016

Médico solicitante: Dr(a). Luciano Augusto Rotella Braga.

Laudo de Polissonografia: Resultado

O exame foi iniciado às 22:21 hs e finalizado às 05:49 hs. A latência para início do sono foi de 2,2 min e a latência para o sono REM de 359,5 min. O tempo total de sono (TTS) foi de 421,0 min, com eficiência do sono de 94,0%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 21,0% de estágio N1, 67,2% de estágio N2, 6,7% de estágio N3 e 5,1% de sono REM. O tempo acordado após o início do sono foi de 24,8 min.

Ocorreram 226 despertares, sendo o índice de 32,2 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros foi de 33,1 (nº/h), sendo 1,1 (nº/h) associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 166, sendo 10 apneias obstrutivas, 2 apneias centrais, 0 apneias mistas, 147 hipopneias e 7 "RERAs".

O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 23,8 (nº/h). O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 22,8 (nº/h).

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) basal foi de 94,7%, a média de 94,5% e a mínima de 85,0%. O índice de dessaturação foi de 13,2 (nº/h) durante o sono. Permaneceu 0,2% do tempo total de sono com SpO₂ abaixo de 90%.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apneia + Hipopneia + RERA

Conclusão:

1. Moderado aumento no índice de apneia/hipopneia (22,8 eventos/hora);
2. Redução da saturação da oxi-hemoglobina com eventos respiratórios;
3. Presença de ronco durante o registro;
4. Aumento da latência para o sono REM;
5. Diminuição da quantidade de sono de ondas lentas e do sono REM;
6. Aumento dos despertares;
7. Aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores.

Dra. Luciana Palombini

CRM: 76102

JORGE LUIZ DE ALMEIDA

Rua Marselhesa, 500 | Vila Clementino | São Paulo - SP | Brasil
CEP 04020-060 | www.sono.org.br

Nome: JORGE LUIS DE ALMEIDA

Data de Nascimento: 30-5-1957

IMC: 26,49

Sexo: Masculino

Data do exame: 12-05-2022

Peso: 73 kg

Altura: 1,66 m

Médico: DRA. ALESSANDRA SILVEIRA

COLOMBI

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 12-05-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corpo, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de sono foi de 248,5, eficiência de 47,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,2%; estágio N2: 65,2%; estágio N3: 11,7%; sono REM: 19,9%. O índice de despertares foi de 15,7/ (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 24,9/hora, sendo elas 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 90%. A frequência cardíaca no estágio I oscilou entre 50 - 79 bpm e NREM de 50 - 81 bpm.

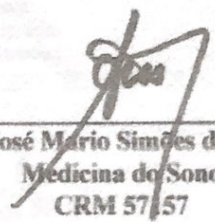
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de So-
escala de Epworth (14), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 24,9/hora;
4. não houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=90%);
5. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (17,6/hora);
9. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau moderado associado a distúrbio movimento.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

Nome: JORGE LUIZ DE ALMEIDA

Data de Nascimento: 30-5-1957

IMC: 26,49

Sexo: Masculino

Data do exame: 20-07-2022

Peso: 73 kg

Altura: 1,66 m

Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia tipo "Split Nigh"

Exame realizado na noite de 20-07-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 246,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 21,0 e 196,5 minutos. O tempo total de sono foi de 135,5, eficiência de 55,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,2%; estágio N2: 63,5%; estágio N3: 24,7%; sono REM: 9,6%. O índice de despertares foi de 4,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 16,8/hora, sendo elas 2 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 36 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 89%, permanecendo 0,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 54 - 71 bpm e NREM de 54 - 79 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (08), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem dos estágios N2 e N3 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 16,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=89%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. número de despertares breves normal;
7. registro de ronco moderado durante o sono.

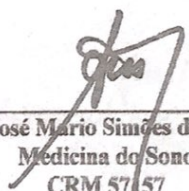
Exame polissonográfico Split-Night evidenciando na primeira parte da noite apnéia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157